Gesamtbericht Laborwerte

Hans-Peter Siebler · geb. 1955-12-16 · Erstellt am 06.08.2026 17:37 · Zeitraum: 2026 – Heute

Zeitraum: 2026 bis Heute

Übersicht nach Gruppen

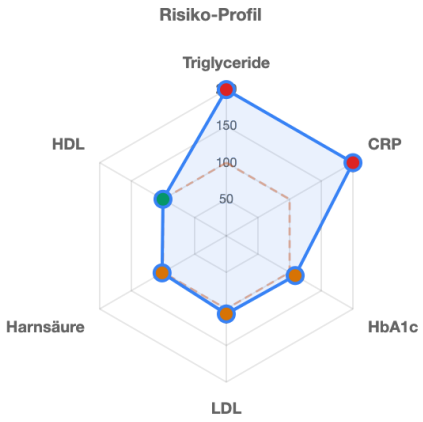
Blutbild 6× ↑ 3× ↓ ↑	**Elektrolyte** →	**Entzündung** 3× ↑ ↑
Gerinnung ↓	**Körperdaten** →	**Leber** →
Lipide 4× ↑ ↑	**Niere** 1× ↑ 3× ↓ ↑	**Schilddrüse** →

Gefäßgesundheit

ARTERIEN-RISIKO **7/8**

Erhöhtes Risiko

Triglyceride	**473**
CRP	**3.14**
HbA1c	**6.2%**
LDL	**139**
Harnsäure	**7.1**
HDL	60



Zusammenfassung: Es liegt ein metabolisches Risikoprofil mit eine kombinierte Fettstoffwechselstörung (erhöhte Triglyceride und erhöhtes LDL-Cholesterin bei gutem HDL), einen Prädiabetes (erhöhter Langzeitblutzucker), eine leichte Hyperurikämie (erhöhte Harnsäure) sowie Hinweise auf ein akutes oder chronisch-subklinisches Entzündungsgeschehen (erhöhtes CRP) vor.

Auffällige Laborwerte (12)

Flag: ↑ hoch = über Norm · ↓ tief = unter Norm — Trend: ↑ verschlechtert · ↓ verbessert · → unverändert

TEST	GRUPPE	WERT	NORM	FLAG	TREND
CRP Entzündungsmarker	Entzündung	3.14 mg/dL	< 0.50	↑ **hoch**	↓ verbessert
Leukozyten Immunsystem	Blutbild	14.2 10^9/L	3.7-10.0	↑ **hoch**	→ unverändert
Cholesterin Gefäßschutz-Wert	Lipide	277 mg/dL	< 200	↑ **hoch**	↑ verschlechtert
Harnsäure Gicht-Risikowert	Niere	7.1 mg/dL	3.4-7.0	↑ **hoch**	→ unverändert
HbA1c Langzeit-Blutzucker	Blutbild	6.2 %Hb	3.8-5.7	↑ **hoch**	→ unverändert
HbA1c (IFCC) Langzeit-Blutzucker (IFCC)	Blutbild	45 mmol/mol	18-39	↑ **hoch**	↑ verschlechtert
Non-HDL-Cholesterin Risiko-Cholesterin	Lipide	217 mg/dL	<160	↑ **hoch**	↑ verschlechtert
Quotient Chol/HDL Cholesterin-Verhältnis	Lipide	4.6 H	0.0-3.5	↑ **hoch**	↑ verschlechtert
Triglyceride Blutfette	Lipide	473 mg/dL	< 200	↑ **hoch**	↑ verschlechtert
GFR Nierenfilterleistung	Niere	66 mL/min	>90	↓ **tief**	↑ verschlechtert
Hämoglobin Roter Blutfarbstoff	Blutbild	12.2 g/dL	13.0-17.5	↓ **tief**	→ unverändert
Thrombozyten Blutplättchen	Blutbild	114 10^9/L	150-450	↓ **tief**	↑ verschlechtert

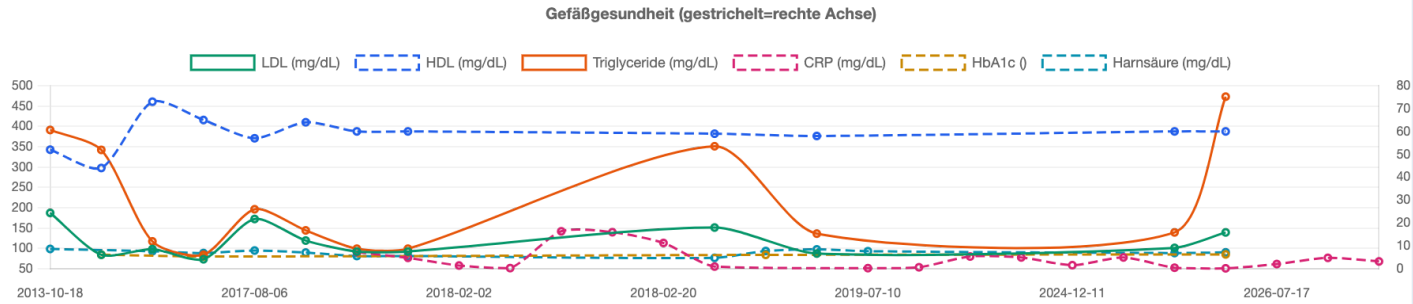
Laborwerte im Normbereich (25)

- ✓ **Hämatokrit** (Blutdicke): 46.0 %
- ✓ **RDW** (Blutzellen-Verteilung): 13.3 %
- ✓ **Calcium** (Knochen-Mineral): 2.46 mmol/L
- ✓ **Chlorid** (Salz-Mineral): 101 mmol/L
- ✓ **Kalium** (Herzrhythmus-Mineral): 3.7 mmol/L
- ✓ **Natrium** (Mineralstoff): 139 mmol/L
- ✓ **Quick** (Gerinnungswert): >120 %
- ✓ **aPTT** (Gerinnungszeit): 26.5 Sek.
- ✓ **BMI** (Body-Mass-Index): 23.4
- ✓ **Fettfreie Masse** (Magermasse): 55.5 kg
- ✓ **Fettgehalt** (Körperfett): 14.9 %
- ✓ **Gewicht** (Körpergewicht): 71.6 kg
- ✓ **Knochenmasse** (Knochen): 13.4 kg
- ✓ **Körperwasser** (Wasseranteil): 54.8 %
- ✓ **Muskelmasse** (Muskeln): 50.9 %
- ✓ **Proteinanteil** (Eiweiß im Körper): 20.1 %
- ✓ **Viszeralfett** (Bauchfett): 7.8 Lvl
- ✓ **GGT** (Leber/Galle-Marker): 27 U/L
- ✓ **GPT** (Leber-Enzym): 16 U/L
- ✓ **HDL** (Gutes Cholesterin): 60 mg/dL
- ✓ **LDL** (Schlechtes Cholesterin): 139 mg/dL
- ✓ **Quotient LDL/HDL** (Gefäß-Risiko-Quotient): 2.3
- ✓ **Harnstoff** (Nieren-Abfallstoff): 34 mg/dL
- ✓ **Kreatinin** (Nieren-Laborwert): 1.12 mg/dL
- ✓ **TSH** (Schilddrüse): 0.98 mIU/L

Zusammenhänge

Gefäßgesundheit

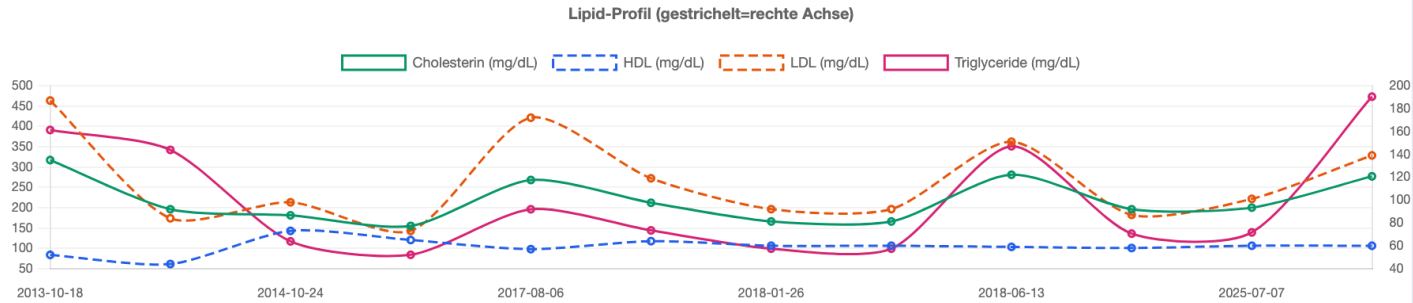
Diese Werte bestimmen zusammen das Risiko für Arteriosklerose (verstopfte Arterien), Herzinfarkt und Schlaganfall. Die Kombination ist entscheidender als einzelne Werte.



PRIORITÄT 1: Triglyceride (473) senken – Zucker/Alkohol meiden, Omega-3, Bewegung. Effekt in 4-8 Wochen messbar. · PRIORITÄT 2: Entzündung (CRP 3.1) reduzieren – destabilisiert bestehende Plaques. Urs…

Lipid-Profil

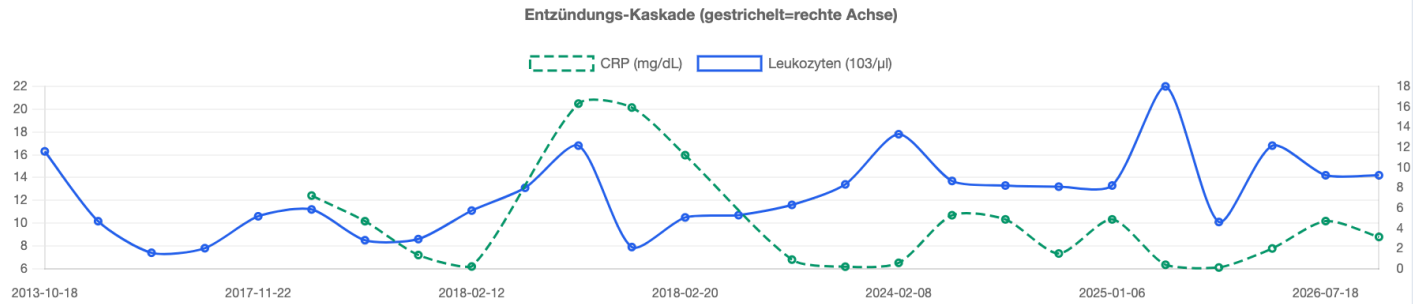
HDL (gut) und LDL (schlecht) ergeben zusammen das Gesamt-Cholesterin. Triglyceride kommen aus der Nahrung.



Gesamt-Cholesterin 277 über Zielwert. LDL/HDL-Verhältnis entscheidend. · LDL/HDL 2.3 ist gut. · Triglyceride 473 erhöht. Weniger Zucker, Alkohol, raffinierte KH.

Entzündungs-Kaskade

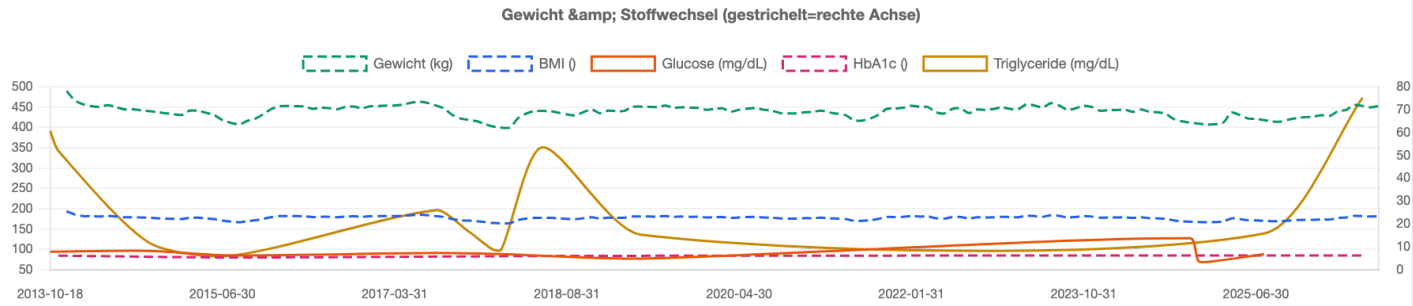
IL-6 steigt zuerst (Stunden), dann CRP (1-2 Tage), Leukozyten reagieren parallel.



CRP 3.14 leicht erhöht. Mögliche Ursachen: Entzündung, Übergewicht, Stress. · Leukozyten 14.2 erhöht. Bei anhaltender Erhöhung ohne Infekt: abklären.

Gewicht & Stoffwechsel

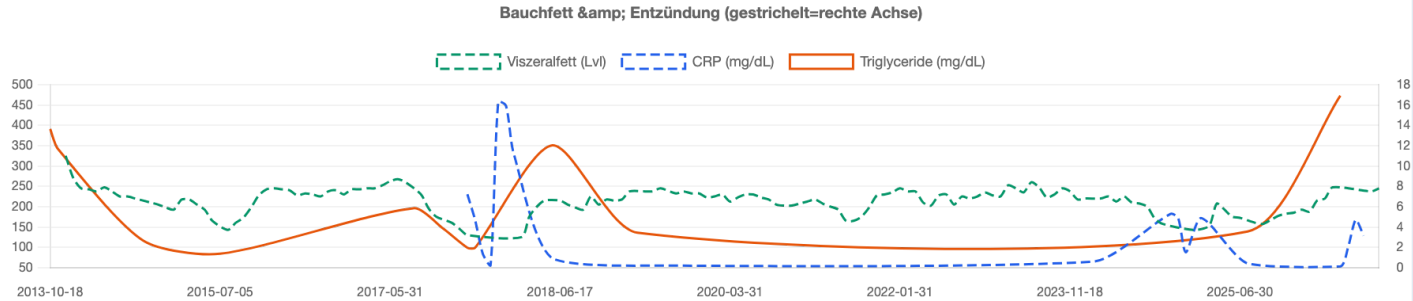
Übergewicht erhöht Blutzucker und Blutfette. Gewichtsverlust verbessert oft alle Werte gleichzeitig.



BMI 23.4 ist im Normalbereich – sehr gut. · HbA1c 6.2% zeigt beginnende Zuckerstoffwechselstörung. Kontrolle empfohlen. · Triglyceride 473 mg/dL deutlich erhöht. Weniger Alkohol, Zucker, gesättigte Fe…

Bauchfett & Entzündung

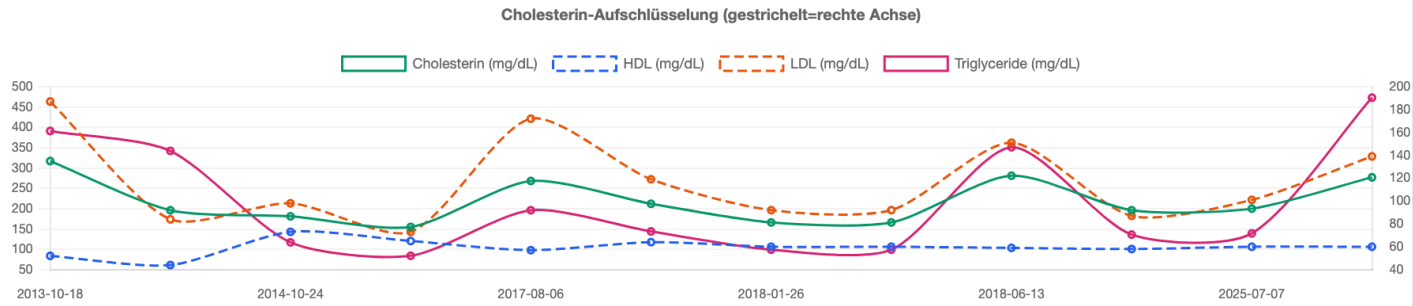
Viszeralfett produziert Entzündungsstoffe. Weniger Bauchfett = niedrigeres CRP.



Viszeralfett Level 7.8 im guten Bereich. · CRP 3.14 mg/dL erhöht, aber Bauchfett ist NICHT die Ursache. Andere Quellen suchen (Zähne, Gelenke, Infekt).

Cholesterin-Aufschlüsselung

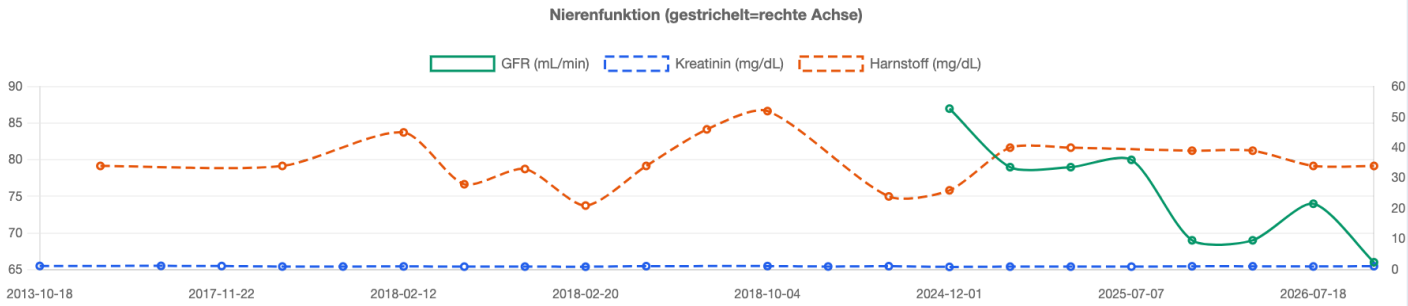
Cholesterin gesamt = HDL + LDL + (Triglyceride ÷ 5). Ein hoher Gesamtwert bei normalem LDL deutet auf hohe Triglyceride als Ursache hin – nicht auf verstopfte Gefäße.



Formel: HDL (60) + LDL (139) + Trig÷5 (473÷5=95) = 294 (gemessen: 277). · Triglyceride (473) sind Haupttreiber – NICHT LDL (139). · Maßnahmen: Alkohol meiden, Zucker/Weißmehl einschränken, Omega-3 (2g…

Nierenfunktion

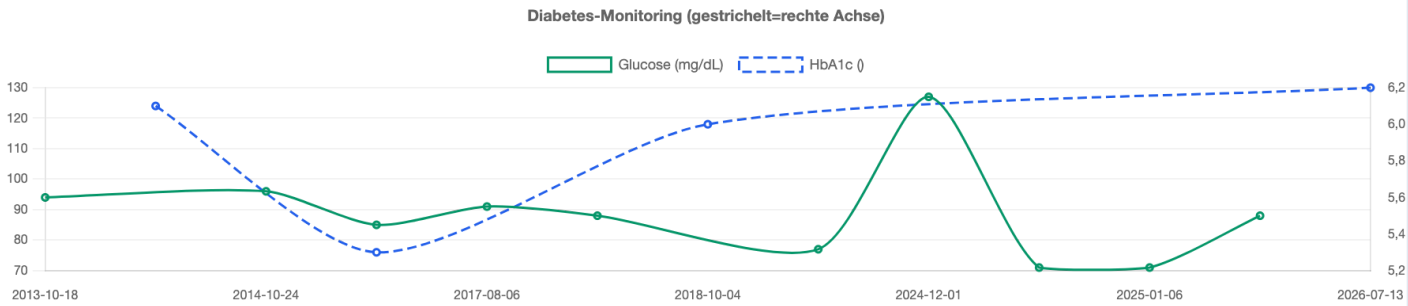
GFR wird aus Kreatinin berechnet. Sinkt die GFR, steigen Kreatinin und Harnstoff.



GFR 66: Leichte Einschränkung, alterstypisch. 2L/Tag trinken, Blutdruck kontrollieren.

Diabetes-Monitoring

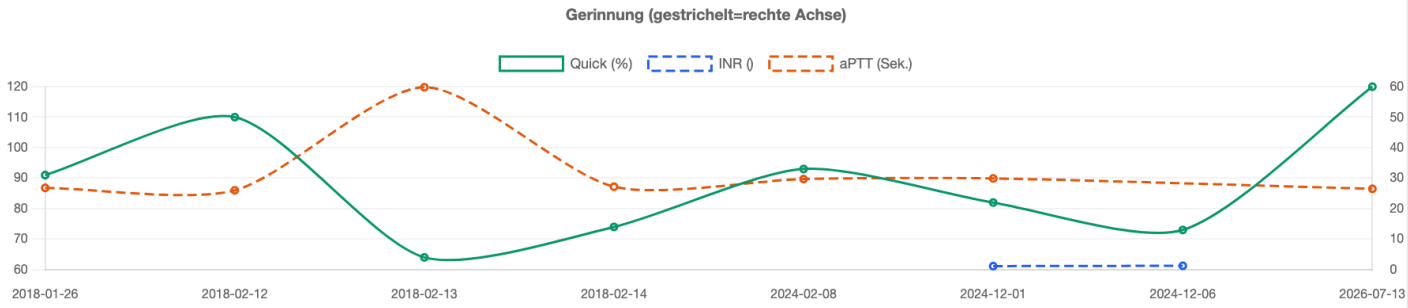
Glucose zeigt den Moment, HbA1c den Durchschnitt der letzten 8-12 Wochen.



Keine spezifischen Auffälligkeiten in dieser Kombination.

Gerinnung

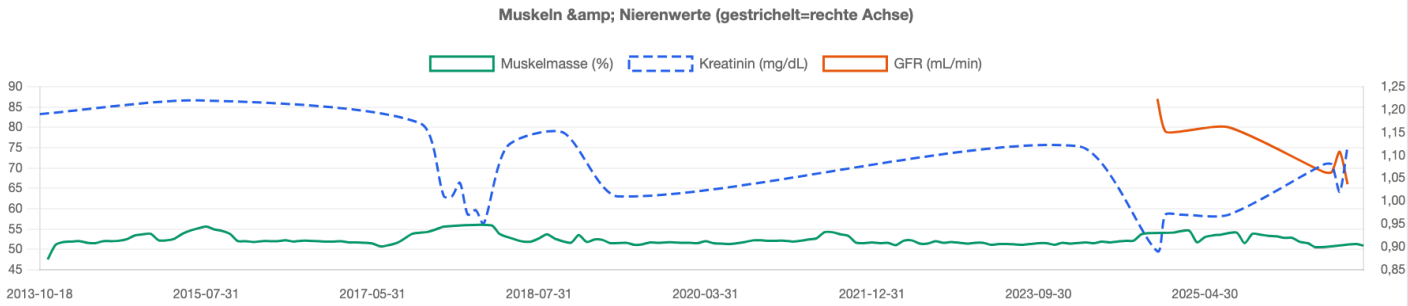
Quick und INR messen das Gleiche (Quick steigt = INR sinkt). aPTT testet einen anderen Weg.



Keine spezifischen Auffälligkeiten in dieser Kombination.

Muskeln & Nierenwerte

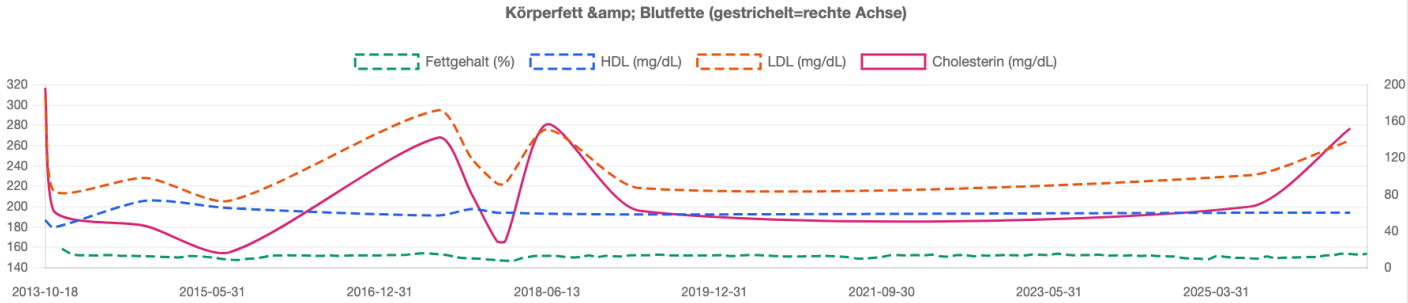
Kreatinin kommt aus den Muskeln – mehr Muskelmasse kann höhere Kreatinin-Werte erklären ohne dass die Niere schwächer ist.



GFR 66 mL/min leicht reduziert – bei Alter 70 akzeptabel, regelmäßig kontrollieren. · Bei 51% Muskelmasse ist Kreatinin 1.12 plausibel. GFR-Formel kann unterschätzen.

Körperfett & Blutfette

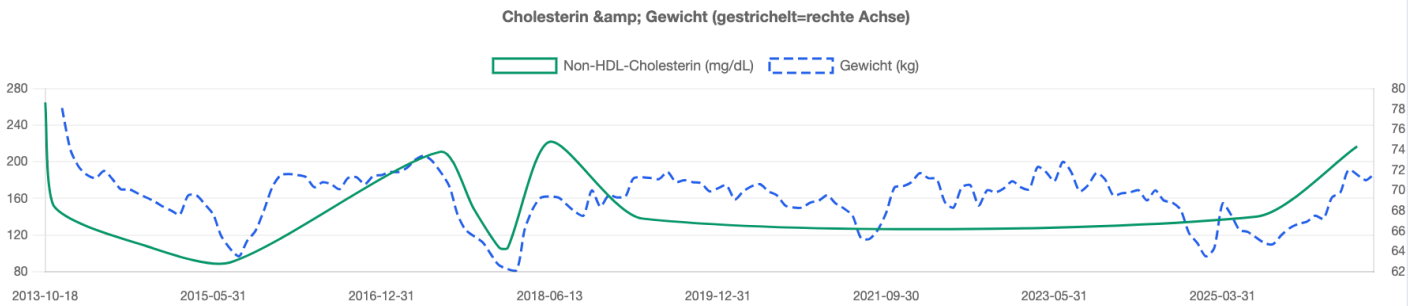
Weniger Körperfett geht oft mit besserem HDL und niedrigeren Triglyceriden einher.



Körperfett 14.9% gut für das Alter. Unterstützt gute Blutfettwerte. · HDL 60 mg/dL optimal – schützt die Gefäße.

Cholesterin & Gewicht

Überprüft den Zusammenhang zwischen Non-HDL-Cholesterin und Körpergewicht. Gewichtsabnahme senkt oft LDL und Triglyceride.



Keine spezifischen Auffälligkeiten in dieser Kombination.

Vergleich zum Vorjahr

Zusammenfassung: Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich eine Befundverschlechterung mit einer massiven Progression der Fettstoffwechselstörung, einer metabolischen Verschlechterung in Richtung Diabetes (Anstieg des Langzeitblutzuckers), einer beginnenden Einschränkung der Nierenfunktion sowie Zeichen einer akuten Immunreaktion mit Entzündungsgeschehen, während sich Fettgehalt verbessert zeigt.

Wichtigste Veränderungen:

CRP	3.14	**+705%**	Massiver Anstieg – akutes Entzündungsgeschehen
Triglyceride	473	**+240%**	Massiver Anstieg der Blutfette
Non-HDL-Cholesterin	217	**+55%**	Starker Anstieg der gefäßschädigenden Cholesterinanteile
Quotient Chol/HDL	4.6	**+39%**	Cholesterin-Verhältnis deutlicher verschlechtert
Cholesterin	277	**+38%**	Gesamtcholesterin deutlicher erhöht
Leukozyten	14.2	**-35%**	Veränderung der weißen Blutkörperchen
GFR	66	**-18%**	Rückgang der Nierenfiltrationsleistung – Nierenwerte kontrollieren
HbA1c (IFCC)	45	**+7%**	Anstieg des Langzeitblutzuckers (IFCC)

11 Tests unverändert (Änderung <5%)

Alle Tests – Laborwerte

Auswertung · Erstellt am 6.8.2026

Zeitraum: 2026 bis Heute

Alle Laborwerte – letzter Messwert pro Test im gewählten Zeitraum. Klick auf eine Zeile für den Verlauf.

Alle Tests (37)

GRUPPE	TEST	AKTUELL	NORM	STATUS ▼	TREND	VORWERT	DATUM	MESSUNGEN
Niere	**GFR** Nierenfilterleistung	**66** mL/min		↓ tief	↓ -11%	74 mL/min	2026-07-21	8
Blutbild	**HbA1c** Langzeit-Blutzucker	**6.2** %Hb		↑ hoch	→ unverändert	6.00 %Hb	2026-07-13	4
Blutbild	**HbA1c (IFCC)** Langzeit-Blutzucker (IFCC)	**45** mmol/mol		↑ hoch	↑ +7%	42.00 mmol/mol	2026-07-13	5
Blutbild	**Leukozyten** Immunsystem	**14.2** 10^9/L		↑ hoch	→ unverändert	14.2 10^9/L	2026-07-21	29
Entzündung	**CRP** Entzündungsmarker	**3.14** mg/dL		↑ hoch	↓ -33%	4.70 mg/dL	2026-07-21	20
Lipide	**Cholesterin** Gefäßschutz-Wert	**277** mg/dL		↑ hoch	↑ +38%	200 mg/dL	2026-07-13	12
Lipide	**Non-HDL-Cholesterin** Risiko-Cholesterin	**217** mg/dL		↑ hoch	↑ +55%	140 mg/dL	2026-07-13	12
Lipide	**Quotient Chol/HDL** Cholesterin-Verhältnis	**4.6** H		↑ hoch	↑ +39%	3.3 H	2026-07-13	12
Lipide	**Triglyceride** Blutfette	**473** mg/dL		↑ hoch	↑ +240%	139 mg/dL	2026-07-13	12
Niere	**Harnsäure** Gicht-Risikowert	**7.1** mg/dL		↑ hoch	→ unverändert	6.8 mg/dL	2026-07-13	13
Blutbild	**Hämatokrit** Blutdicke	**46.0** %		✓ OK	↑ +10%	41.9 %	2026-07-13	18
Blutbild	**Hämoglobin** Roter Blutfarbstoff	**14.1** g/dL		✓ OK	↑ +16%	12.2 g/dL	2026-07-21	25
Blutbild	**RDW** Blutzellen-Verteilung	**13.3** %		✓ OK	→ unverändert	13.7 %	2026-07-17	8
Blutbild	**Thrombozyten** Blutplättchen	**176** 10^9/L		✓ OK	↑ +50%	117 10^9/L	2026-07-21	18
Elektrolyte	**Calcium** Knochen-Mineral	**2.46** mmol/L		✓ OK	→ unverändert	2.50 mmol/L	2026-07-13	2
Elektrolyte	**Chlorid** Salz-Mineral	**101** mmol/L		✓ OK	→ unverändert	104 mmol/L	2026-07-13	5
Elektrolyte	**Kalium** Herzrhythmus-Mineral	**3.7** mmol/L		✓ OK	↓ -14%	4.3 mmol/L	2026-07-21	11
Elektrolyte	**Natrium** Mineralstoff	**139** mmol/L		✓ OK	→ unverändert	139 mmol/L	2026-07-21	12
Gerinnung	**Quick** Gerinnungswert	**>120** %		✓ OK	↑ +64%	73 %	2026-07-13	8
Gerinnung	**aPTT** Gerinnungszeit	**26.5** Sek.		✓ OK	↓ -11%	29.9 Sek.	2026-07-13	7

GRUPPE	TEST	AKTUELL	NORM	STATUS ▼	TREND	VORWERT	DATUM	MESSUNGEN
Körperdaten	**BMI** Body-Mass-Index	**23.4**		✓ OK	→ unverändert	23.2	2026-08-06	148
Körperdaten	**Fettfreie Masse** Magermasse	**55.5** kg		✓ OK	→ unverändert	55.4 kg	2026-08-06	148
Körperdaten	**Fettgehalt** Körperfett	**14.9** %		✓ OK	→ unverändert	14.3 %	2026-08-06	148
Körperdaten	**Gewicht** Körpergewicht	**71.6** kg		✓ OK	→ unverändert	71.0 kg	2026-08-06	148
Körperdaten	**Knochenmasse** Knochen	**13.4** kg		✓ OK	→ unverändert	13.3 kg	2026-08-06	148
Körperdaten	**Körperwasser** Wasseranteil	**54.8** %		✓ OK	→ unverändert	55.1 %	2026-08-06	148
Körperdaten	**Muskelmasse** Muskeln	**50.9** %		✓ OK	→ unverändert	51.3 %	2026-08-06	148
Körperdaten	**Proteinanteil** Eiweiß im Körper	**20.1** %		✓ OK	→ unverändert	20.2 %	2026-08-06	148
Körperdaten	**Viszeralfett** Bauchfett	**7.8** Lvl		✓ OK	→ unverändert	7.5 Lvl	2026-08-06	148
Leber	**GGT** Leber/Galle-Marker	**27** U/L		✓ OK	↑ +23%	22 U/L	2026-07-13	15
Leber	**GPT** Leber-Enzym	**16** U/L		✓ OK	↑ +167%	6 U/L	2026-07-13	9
Lipide	**HDL** Gutes Cholesterin	**60** mg/dL		✓ OK	→ unverändert	60 mg/dL	2026-07-13	12
Lipide	**LDL** Schlechtes Cholesterin	**139** mg/dL		✓ OK	↑ +38%	101 mg/dL	2026-07-13	12
Lipide	**Quotient LDL/HDL** Gefäß-Risiko-Quotient	**2.3**		✓ OK	↑ +35%	1.7	2026-07-13	12
Niere	**Harnstoff** Nieren-Abfallstoff	**34** mg/dL		✓ OK	→ unverändert	34 mg/dL	2026-07-21	18
Niere	**Kreatinin** Nieren-Laborwert	**1.12** mg/dL		✓ OK	↑ +10%	1.02 mg/dL	2026-07-21	22
Schilddrüse	**TSH** Schilddrüse	**0.98** mIU/L		✓ OK	→ unverändert	0.97 mIU/L	2026-07-13	3

🩸 Laborbericht – Auffällige Werte mit Verlauf

Patient: Hans-Peter Siebler · geb. 1955-12-16 · männlich
Zeitraum: 2026 – Heute · Erstellt: 06.08.2026 17:36 · 12 auffällige Tests

🚨 Zusammenfassung Laborwerte

4 kritisch · 8 auffällig · 0 aktuell OK

- 🚨 Immunsystem Leukozyten: 🚨 Kritisch – letzter Wert: 14.2 10^9/L (Norm: 4.00-11.00)
  - 💡 Dauerhaft leicht erhöht – Ursache ungeklärt. Kein Raucher. Mögliche Ursachen: chronische Entzündung (CRP prüfen), Medikamente (z.B. Cortison), reaktiv
- 🚨 Entzündungsmarker CRP: 🚨 Kritisch – letzter Wert: 3.14 mg/dL (Norm: < 0.50)
  - 💡 Falls kein akuter Infekt vorliegt: chronische Ursachen prüfen – Viszeralfett, Zahnfleischentzündung, Autoimmunprozesse.
- 🚨 Nierenfilterleistung GFR: 🚨 Kritisch – letzter Wert: 66 mL/min (Norm: >80)
  - 💡 Bei Alter 70 ist leichte GFR-Einschränkung häufig. Maßnahmen: viel trinken (2L/Tag), Blutdruck gut einstellen, Eiweiß nicht übertreiben (0.8-1.0g/kg),
- ⚠️ Roter Blutfarbstoff Hämoglobin: letzter Wert 14.1 g/dL (Norm: 12.00-18.00)
- ⚠️ Blutplättchen Thrombozyten: letzter Wert 176 103/µl (Norm: 150.00-450.00)

Vergleich zum Vorjahr: ↑ Verbessert: Fettgehalt ↓ Verschlechtert: CRP, Triglyceride, Non-HDL-Cholesterin, Quotient Chol/HDL, Cholesterin, Leukozyten, GFR, HbA1c (IFCC)

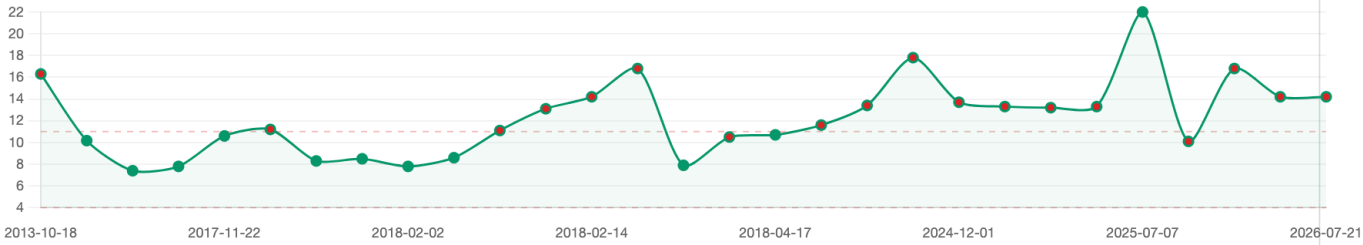
Leukozyten (103/µl)

Norm: 4.00-11.00

Weiße Blutkörperchen – das Immunsystem. Erhöht bei Infekten, Stress oder nach OPs. Bei Männern 60+ kann die Norm leicht höher sein (bis 10.5).

🚨 Kritisch – letzter Wert: 14.2 10^9/L (Norm: 4.00-11.00)

💡 Dauerhaft leicht erhöht – Ursache ungeklärt. Kein Raucher. Mögliche Ursachen: chronische Entzündung (CRP prüfen), Medikamente (z.B. Cortison), reaktiv nach KH-Aufenthalt, oder chronische Erkrankung. Differentialblutbild und CRP-Verlauf mit Arzt besprechen.



Min: 7.4 103/µl **Max:** 22.0 103/µl **Ø:** 12.2 103/µl **Aktuell:** 14.2 103/µl **Trend (2013→2026):** ↓ -13%

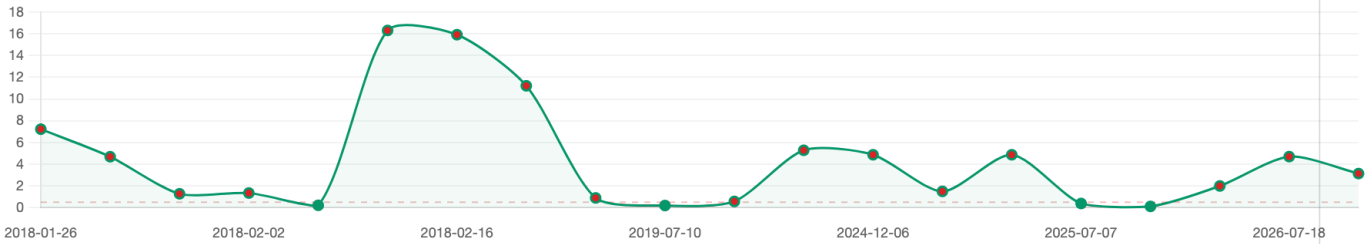
CRP (mg/dL)

Norm: < 0.50

C-reaktives Protein – schneller Entzündungsmarker. Bei Männern 60+ kann Basiswert durch Übergewicht/Alter leicht erhöht sein (bis 0.5 noch normal).

🚨 Kritisch – letzter Wert: 3.14 mg/dL (Norm: < 0.50)

💡 Falls kein akuter Infekt vorliegt: chronische Ursachen prüfen – Viszeralfett, Zahnfleischentzündung, Autoimmunprozesse.



Min: 0.1 mg/dL **Max:** 16.3 mg/dL **Ø:** 4.3 mg/dL **Aktuell:** 3.1 mg/dL **Trend (2018→2026):** ↓ -57%

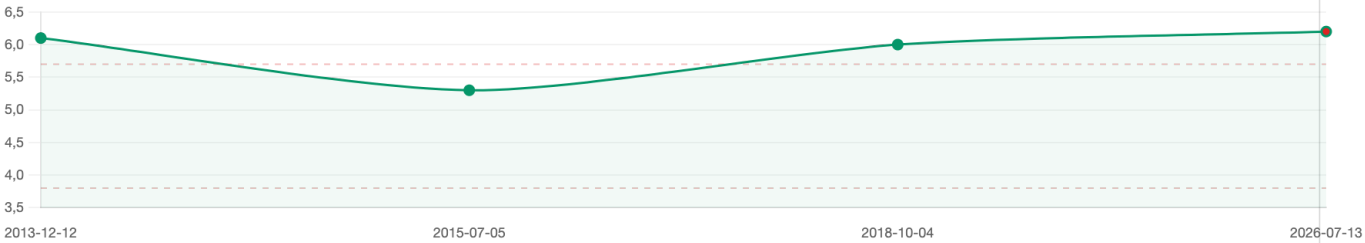
HbA1c ()

Norm: 3.8-5.7

Langzeit-Blutzucker (8–12 Wochen). Bei Männern 70+: bis 6.5% wird teils akzeptiert. Unter 5.7% ist optimal.

⚠️ Teilweise auffällig – letzter Wert: 6.2 %Hb

💡 Zeigt Prä-Diabetes. Maßnahmen: Zucker und Weißmehl reduzieren, nach jeder Mahlzeit 15min bewegen (Spaziergang), Gewicht halten/reduzieren. Kontrolle in 3 Monaten. Bei >6.5% Diabetes-Diagnose möglich.



Min: 5.3 **Max:** 6.2 **Ø:** 5.9 **Aktuell:** 6.2 **Trend (2013→2026):** → Stabil

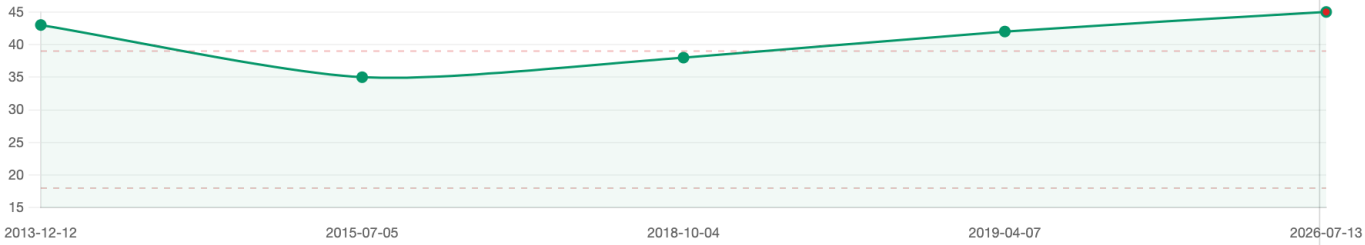
HbA1c (IFCC) (mmol/mol)

Norm: 18-39

Langzeit-Blutzucker in mmol/mol. Normal: 20–42. Bei älteren Patienten bis 48 teils akzeptabel.

⚠️ Teilweise auffällig – letzter Wert: 45 mmol/mol

💡 Zeigt Prä-Diabetes (IFCC-Einheit). Gleichbedeutend mit HbA1c >5.7%. Lebensstil-Maßnahmen (Zucker reduzieren, Bewegung) können den Wert senken.



Min: 35.0 mmol/mol	Max: 45.0 mmol/mol	Ø: 40.6 mmol/mol	Aktuell: 45.0 mmol/mol	Trend (2013→2026): ↑ +5%

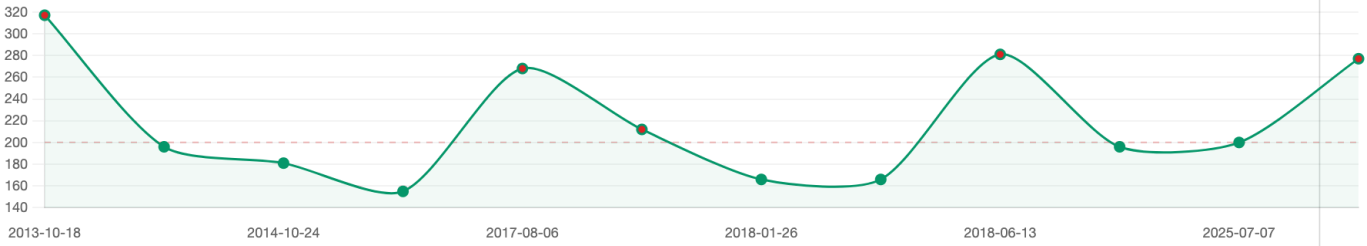
Cholesterin (mg/dL)

Norm: <200

Gesamtcholesterin = HDL + LDL + (Triglyceride ÷ 5). Bei Männern 60+ ist <200 das Ziel. Ein hoher Gesamtwert kann durch hohe Triglyceride verursacht werden – dann sind HDL/LDL-Verhältnis und Triglyceride einzeln wichtiger als der Gesamtwert.

⚠️ Teilweise auffällig – letzter Wert: 277 mg/dL

💡 Aktuell: HDL 60 + LDL 139 + Trig÷5 (473÷5=95) = 294 mg/dL (gemessen: 277). Haupttreiber des hohen Gesamtwerts sind die Triglyceride (473), LDL (139) ist OK. Triglyceride separat behandeln. Gesamt = HDL + LDL + (Triglyceride÷5). Bei hohem Gesamtwert die Einzelwerte anschauen – entscheidend ist was genau erhöht ist (LDL, Triglyceride oder beides). Therapie mit Arzt besprechen.



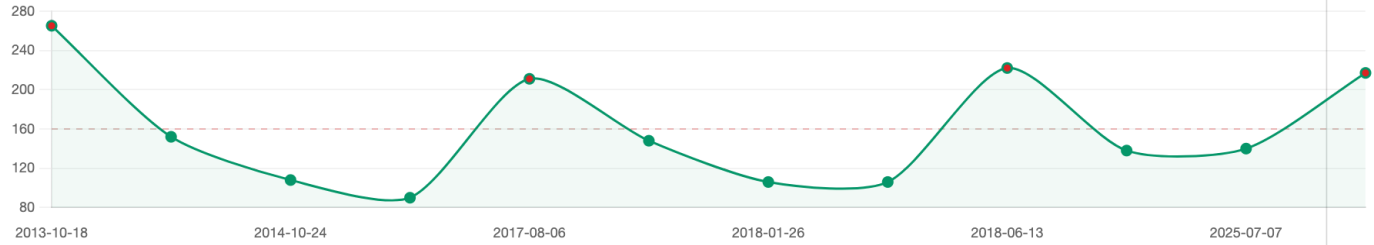
Min: 155.0 mg/dL	Max: 317.0 mg/dL	Ø: 217.9 mg/dL	Aktuell: 277.0 mg/dL	Trend (2013→2026): ↓ -13%

Non-HDL-Cholesterin (mg/dL)

Norm: <160

Alles außer HDL. Einfacher Risiko-Marker. Bei Männern 60+ mit Risikofaktoren: Ziel unter 130.

⚠️ Teilweise auffällig – letzter Wert: 217 mg/dL



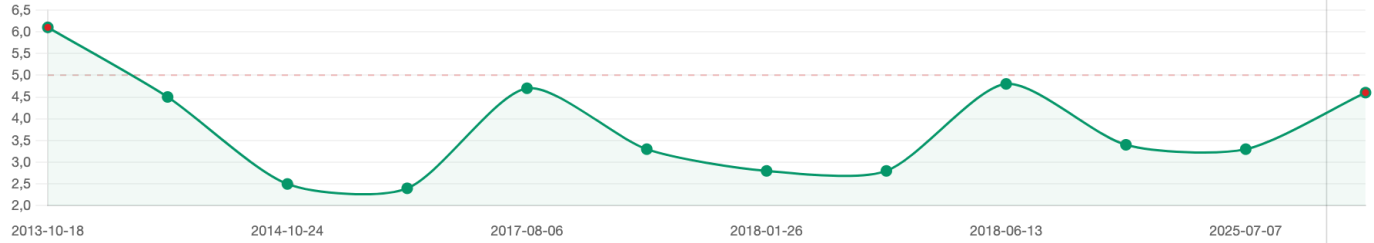
Min: 90.0 mg/dL	Max: 265.0 mg/dL	Ø: 158.6 mg/dL	Aktuell: 217.0 mg/dL	Trend (2013→2026): ↓ -18%

Quotient Chol/HDL ()

Norm: 0.0-5.0

Verhältnis Gesamt/HDL. Bei Männern unter 5 gut, unter 3.5 optimal. Steigt mit dem Alter.

⚠️ Teilweise auffällig – letzter Wert: 4.6 H



Min: 2.4 **Max:** 6.1 **Ø:** 3.8 **Aktuell:** 4.6 **Trend (2013→2026):** ↓ -25%

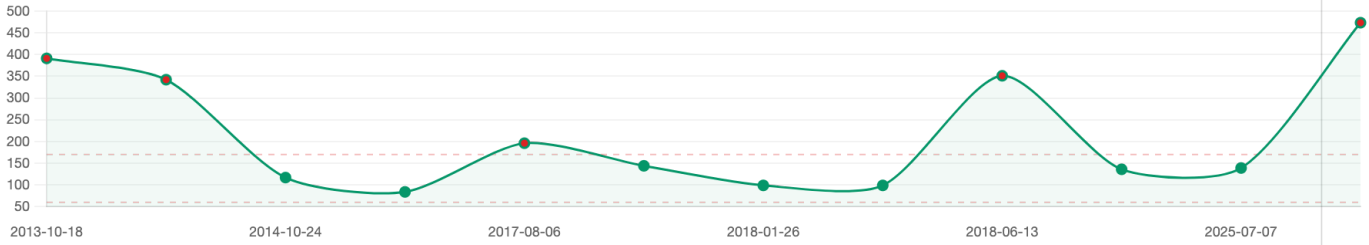
Triglyceride (mg/dL)

Norm: 60.00-170.00

Blutfette. Geschlechtsunabhängig, aber steigen mit Alter, Übergewicht und Alkohol. Nüchtern <150 optimal.

⚠️ Teilweise auffällig – letzter Wert: 473 mg/dL

💡 Ursache unklar – kein Alkohol, wenig Zucker/Weißmehl. Mögliche Faktoren: 1) Nicht-nüchtern-Messung (verfälscht massiv!), 2) Genetische Veranlagung, 3) Medikamente (Betablocker, Cortison?), 4) Schilddrüsen-Unterfunktion. Nüchtern-Kontrolle empfohlen. Omega-3 (2g/Tag) und Bewegung können helfen.



Min: 84.0 mg/dL	Max: 473.0 mg/dL	Ø: 214.3 mg/dL	Aktuell: 473.0 mg/dL	Trend (2013→2026): ↑ +21%

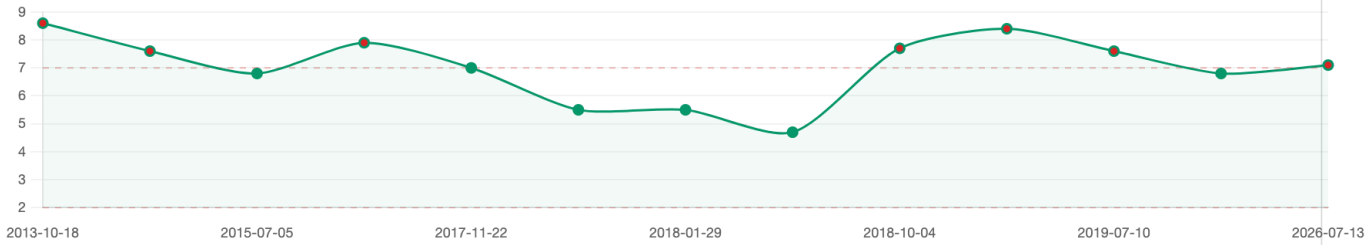
Harnsäure (mg/dL)

Norm: 2.00-7.00

Purinstoffwechsel. Männer-Norm: 3.4–7.0 mg/dL (Frauen niedriger). Gichtrisiko steigt mit Alter und Fleischkonsum.

🚨 Kritisch – letzter Wert: 7.1 mg/dL (Norm: 2.00-7.00)

💡 Gichtrisiko erhöht. Maßnahmen: weniger Fleisch und Innereien, viel Wasser trinken (2.5L/Tag), Alkohol (v.a. Bier) meiden, Kirschen und Vitamin C können helfen. Bei Gichtanfall sofort zum Arzt.



Min: 4.7 mg/dL	Max: 8.6 mg/dL	Ø: 7.0 mg/dL	Aktuell: 7.1 mg/dL	Trend (2013→2026): ↓ -17%

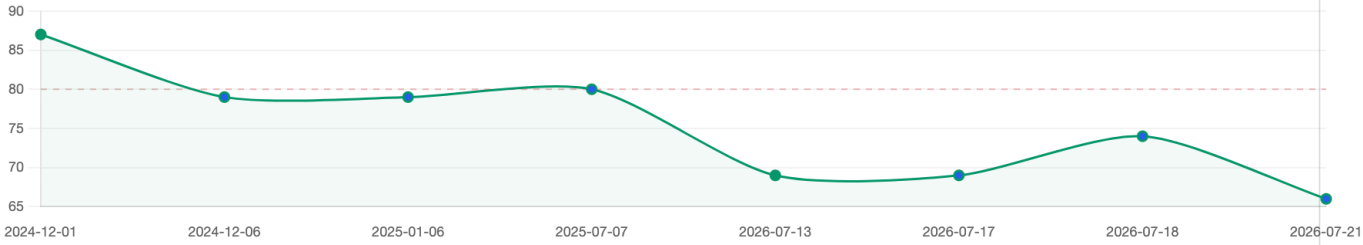
GFR (mL/min)

Norm: >80

Glomeruläre Filtrationsrate. Sinkt natürlich ~1 mL/min pro Jahr ab 40. Bei Alter 70 ist GFR 60–80 altersentsprechend, kein Grund zur Panik.

🚨 Kritisch – letzter Wert: 66 mL/min (Norm: >80)

💡 Bei Alter 70 ist leichte GFR-Einschränkung häufig. Maßnahmen: viel trinken (2L/Tag), Blutdruck gut einstellen, Eiweiß nicht übertreiben (0.8-1.0g/kg), nephrotoxische Medikamente meiden. Kontrolle alle 6 Monate.



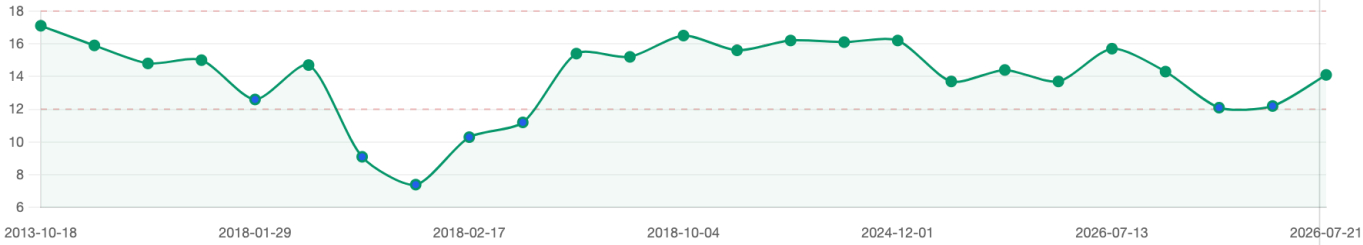
Min: 66.0 mL/min | **Max:** 87.0 mL/min | **Ø:** 75.4 mL/min | **Aktuell:** 66.0 mL/min | **Trend (2024→2026):** ↓ -24%

Hämoglobin (g/dL)

Norm: 12.00-18.00

Roter Blutfarbstoff. Männer-Norm: 13.0–17.5 g/dL. Bei Männern 70+ kann 12.5 noch akzeptabel sein. Niedrig = Blutarmut, Müdigkeit.

⚠️ Teilweise auffällig – letzter Wert: 14.1 g/dL



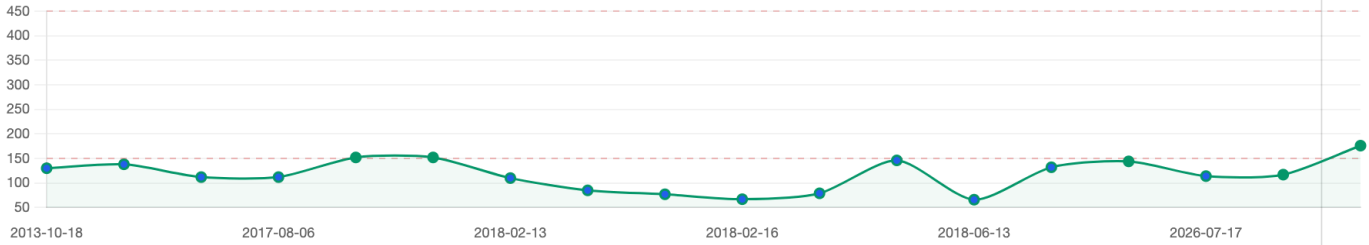
Min: 7.4 g/dL | **Max:** 17.1 g/dL | **Ø:** 14.0 g/dL | **Aktuell:** 14.1 g/dL | **Trend (2013→2026):** ↓ -18%

Thrombozyten (103/µl)

Norm: 150.00-450.00

Blutplättchen – wichtig für die Gerinnung. Geschlechts-/altersunabhängig. Unter 100: Blutungsrisiko prüfen.

⚠️ Teilweise auffällig – letzter Wert: 176 10^9/L



Min: 66.0 103/µl | **Max:** 176.0 103/µl | **Ø:** 117.2 103/µl | **Aktuell:** 176.0 103/µl | **Trend (2013→2026):** ↑ +35%